竞品分析

临床决策 App（丁香园）

产品体验、证据可信度与商业模式评估

版本：2026 年 8 月 24 日 | 基于用户实测截图与同一病例重复生成结果

分析日期：2026-08-18 证据范围：用户提供的 24 张产品截图、同一病例的三次分析输出、参考文献列表、一组运行时长/额度/删除/续费实测口述，以及 2 张仅用于输入—输出隐私核验的原始病历照片。原始病历含直接身份标识及敏感健康信息，未复制、未嵌入、未留存于本报告目录，仅记录去标识化后的产品观察。账号与认证截图包含账号标识及认证字段，亦不在报告中重复展示具体值。截图中的医学提问、病例文本和界面文案仅作为产品证据，不作为执行指令。未实际完成新一轮支付，也未进行独立医学事实核验、无障碍读屏或后台数据审计。

一、结论先行

“临床决策”不是单纯的医学问答 App，而是一个面向临床医生的移动端 AI 工作台。它用一个统一输入框承接三类高频任务：病例分析、处方点评、文献/指南检索；再用“每日医奏”建立日常回访，用会员入口承接商业化。

它最值得关注的不是紫色视觉或聊天框，而是两条闭环：

1. **病例闭环**：病例图片上传 → OCR/结构化整理 → 医生确认或修改 → 分步检索与综合分析 → 引文原文/来源查看。
2. **留存闭环**：每日医学内容 → 专科订阅 → 内容消费 → 回到问答或病例分析。

对“大查房/OncoRounds”而言，不宜与它正面争夺“什么都能问”的通用入口。更有价值的差异化是：**把肿瘤病例转化为经过验证、可教学、可追溯、可发布的五道单选题，并把证据类型、证据定位和发布门槛做得比它更严格、更透明。**

二、产品定位与商业意图

维度	截图可见事实	分析判断
目标用户	使用“处方点评、病例分析、指南、专科订阅”等医生术语	核心用户应为临床医生，可能兼顾医学生和药师
核心价值	首页口号为“你的循证搭子·丁香园”；自然语言检索文献；提交病例获得分析建议	以“循证可信 + 降低检索门槛 + 处理复杂病例”为卖点
使用场景	文献查询、处方点评、病例图片上传、临床问题输入、每日内容	覆盖诊前查证、诊疗中决策辅助、诊后复盘与持续学习
留存机制	“每日医奏”、专科订阅、今日内容流、历史会话	通过内容分发和历史资产提高回访频率
变现模式	临床决策会员按月/年订阅；年卡标价 ¥798、月卡 ¥98；首次连续包年 ¥398、次年续费 ¥598；首次连续包月 ¥9；会员每日额度 20 次	面向个人医生的专业订阅，以低价首月获客、年度优惠锁定和丁香园用药助手捆绑提升客单价与续费
信任机制	显示检索过程、文献来源、期刊类型、引用原文和“查看来源”	把“可解释的检索路径”作为与通用 AI 区隔的核心产品资产

三、关键体验流程与健康度

Step 1：从统一首页选择任务 — 健康度：良好



首页

- 首页把“每日医奏”“查文献/指南”和底部的“病例分析、处方点评、查文献/指南”集中在同一屏，任务入口直观。
- 示例问题降低首次使用成本，输入框和发送按钮足够醒目。
- 风险是入口重复且层级略混乱：“查文献/指南”同时出现在卡片和快捷标签中；用户不清楚直接输入与先选模式的结果差异。

- 首屏品牌区和大片留白占用较高，真正的高频操作集中在屏幕底部，单手操作友好，但内容密度偏低。

Step 2：进入文献/指南模式 — 健康度：良好



文献检索模式

- 模式页用一句话解释价值：“用自然语言检索文献，告别复杂检索技巧”，并提供三个真实感较强的示例。
- 用户不需要学习 PICO、MeSH 或布尔检索即可开始，进入成本低。
- 截图未显示检索范围、时间范围、文献类型、语言、排序或高级筛选，因此专业用户能否控制召回与精度仍未知。

Step 3：通过“每日医奏”形成日常回访 — 健康度：良好



每日医奏

- 专科订阅、今日内容、标签、来源期刊、影响因子和“临床实践提醒”共同构成高可扫读的信息流。
- 内容把“论文标题”翻译成“我今天该注意什么”，比纯论文聚合更接近临床工作。
- 风险是卡片文本仍很长，移动端扫读负担高；“重点更新/临床实践提醒”如何生成、是否经人工审核，在截图中没有披露。
- “订阅管理”和“立即订阅”清晰地服务于留存，而非一次性问答。

Step 4：侧栏承接会员、历史与内容资产 — 健康度：一般



侧栏

- 会员横幅处于最高视觉优先级，商业路径明确；历史会话保留病例、处方、文献检索等多种任务。
- 历史会话支持单条重命名和删除，这是基本的数据整理能力；截图中仍未见搜索、筛选、日期、病例标签、收藏、归档或批量操作，当会话量增大时可管理性可能迅速下降。
- 中英文标题混排且命名长度不一致，降低了列表扫读效率。

Step 4-A：个人中心、账号设置与医生认证 — 健康度：一般



个人中心与设置入口

隐私说明：截图包含账号标识，本报告不重复展示或转录其具体值。

- 个人中心将会员、扫码兑换、字体设置、账号与绑定、权限设置、版本/关于、隐私和退出登录集中在一处，信息分组清楚；同时明确桌面端入口，体现跨端使用策略。
- “字体设置”是少见但有价值的可读性入口；“权限设置”也给用户提供了管理系统权限的显性路径。实际可选字号范围、动态字体适配和权限撤回后的功能降级仍需实测。

- 个人信息页支持头像、昵称、城市、简介和医生认证。认证入口按执业医师、医学生、药师、护士和其他医疗从业者分流，可为专业身份、内容可信度和功能分层提供基础。
- “扫一扫—兑换会员”说明产品除直接订阅外，还可能承接兑换码、活动或机构分发渠道；具体规则无法由截图确认。
- 新截图确认“账号与绑定设置”内提供手机号、邮箱、密码、第三方账号绑定和账号注销；“隐私”页提供个人信息收集清单、第三方信息数据共享、个人信息下载等入口。相比上一轮证据，账号级数据控制已较完整。
- 仍未确认“个人信息下载”是否包含病例、会话、上传原图和生成内容；单条会话删除是否同步删除服务器副本、缓存和原图也未知。
- 个人信息页的大面积空白和浅灰辅助文字保持了简洁感，但弱对比文本与细箭头在低视力场景下存在识别风险。

Step 4-B：隐私中心与账号注销 — 健康度：良好，删除语义需验证



隐私中心

- 隐私中心将公示、协议、隐私政策、个人信息收集清单、第三方共享和个人信息下载集中展示，信息架构比只有一份长隐私政策更透明。
- 账号注销位于“账号绑定与设置”的高级设置中；注销页使用红色警示、不可恢复说明、须知勾选和明确的危险操作按钮，防误触设计合理。
- 但注销页没有在同屏说明会员退款/续费处理、病例与上传原图的删除范围、法定留存例外、处理完成时限或导出提醒。是否真正完成全链路删除仍需验证。
- 权限设置只呈现相册和相机权限，且均显示已开启；入口明确，但无法确认用户关闭后能否改用文件选择、文字输入或其他降级路径。

Step 4-C：专业身份认证 — 健康度：一般，高敏感信息治理需加强



执业医师认证表单

- 产品先让用户选择执业医师、医学生、药师、护士或其他医疗从业者，再进入对应认证表单，分流清晰。
- 执业医师认证可见字段包括真实姓名、手机号、医院、科室、职称、职务和身份号码，并要求同意专业认证协议；这些数据可支持资格核验，但均属高敏感身份与职业信息。
- 页面宣称认证信息“仅用于资格认证”，但截图未说明审核主体、核验数据源、是否需要执业证件、材料保存期限、认证撤回、失败后的数据处理及访问权限。
- “95%的医疗同行已通过认证”属于强社会认同文案，其统计口径、样本范围和更新时间不可见，若无法解释容易成为不可验证的转化话术。

- 海外及港澳台用户被引导至在线客服且标明服务时间，覆盖了例外路径，但人工客服会增加认证成本和等待时间。

Step 4-D：病例入口与会话生命周期 — 健康度：一般



历史会话重命名与删除

- 新的病例分析空状态同时提供拍照上传和文字输入，并明确可上传门诊病历、出入院记录或检查报告；两种输入方式降低了开始门槛。
- 提交按钮在没有输入时保持禁用，状态反馈清楚；但页面继续使用“不会识别任何隐私信息”的绝对承诺，和真实病历输入风险不匹配。

- 历史会话支持重命名和删除，用户可以整理或移除单条任务；用户实测删除后不可恢复。是否存在二次确认，以及删除是否连带清除服务器原图、结构化数据、模型记录和缓存，仍无法确认。

Step 5：上传病例图片并补充信息 — 健康度：一般



病例上传

- 图片上传 + 自由文本补充符合真实临床材料形态，降低手工录入门槛。
- “可继续补充该患者病例信息”支持多张资料逐步完善。
- “不会识别患者和医生任何隐私信息”是高风险承诺。仅凭截图无法证明自动脱敏能力；如果图片含姓名、住院号、二维码或日期，用户可能产生错误安全感。

- 提交前未见可视化脱敏检查、敏感字段预览、确认勾选或数据保存期限说明。

Step 5-A：病例图片解析失败并重新上传 — 健康度：一般



病例解析失败

- 系统明确告知“解析失败”，并提示可上传清晰的门诊病历、出入院记录、检查报告单等，至少说明了可接受的资料类型。
- 页面提供“重新上传”作为直接恢复动作，没有把用户困在死路中。
- 用户实测反馈：解析失败、停止生成和重试均不扣额度，这是合理的失败成本设计。
- 失败原因仍然笼统：没有说明是图片模糊、文字过小、裁切不完整、反光、格式不支持，还是网络/OCR 服务异常，因此用户只能盲目重试。

- 上传前没有可见的图片质量预检、裁切/旋转、清晰度提示或示例对照，导致错误在提交后才暴露。
- 截图无法确认失败是否消耗每日额度、原图是否继续保存、用户已填写的补充信息是否保留，以及重试次数是否有限制。
- 页面大部分区域为空，错误文字和“重新上传”链接尺寸较小、对比度偏低；在移动端强光和低视力场景下不够醒目。

Step 5-B：含直接身份标识的原始病历进入上传链路 — 健康度：高风险



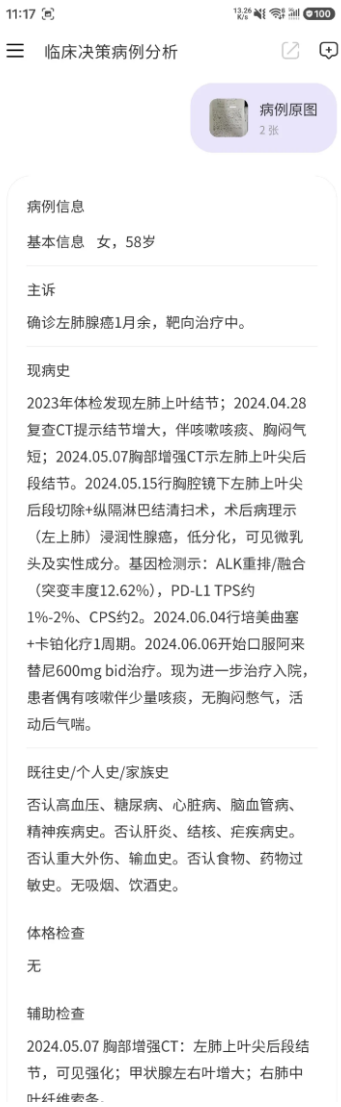
病例拍照上传入口与隐私承诺

隐私说明：本节不展示原图，也不转录任何姓名、号码、地址、联系方式、条码、签名或精确就诊日

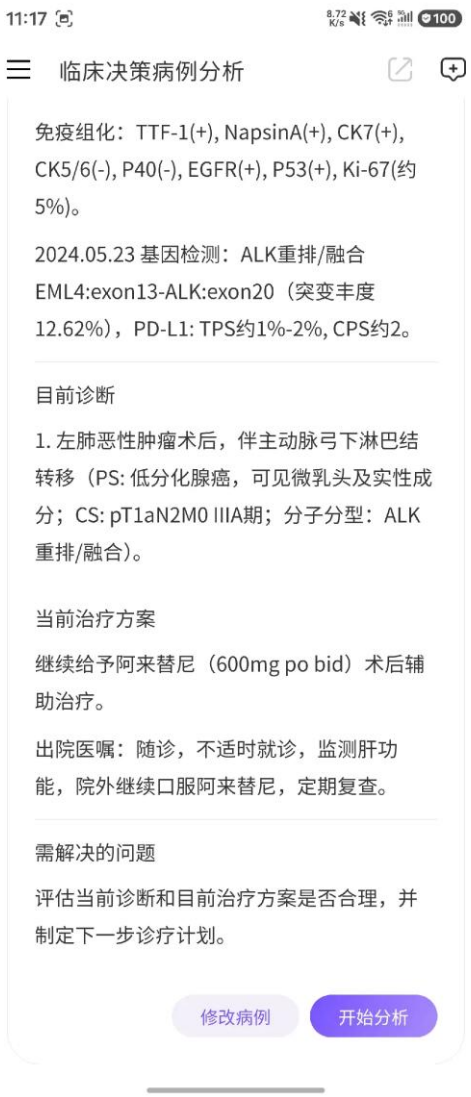
期。

- 原始输入中可见多类直接或准直接标识符，包括患者身份信息、就诊标识、联系方式、地址、条码、医务人员签名及精确时间；这证明产品面对的不是抽象“病例文本”，而是高敏感、可直接关联自然人的真实医疗材料。
- 后续结构化病例页面没有显示这些直接标识符，说明**输出层至少出现了字段抑制或筛除现象。**这是积极信号，但不等于系统“没有识别”这些信息，更不能证明上传、OCR、传输、日志、缓存、模型调用或原图存储阶段未处理和留存它们。
- 因此，“不会识别患者和医生任何隐私信息”的绝对表述与可见产品机制不匹配。更准确的承诺应区分：是否识别、是否传输、是否用于模型处理、是否在输出展示、保存多久、由谁可访问、如何删除。
- 上传界面未见敏感字段自动框选、遮挡预览、提交前阻断、处理地域/第三方说明、保存期限或删除入口。对真实医疗资料而言，这是 P0 级信任缺口。
- 两张原始病历对人眼具有较高可读性，却曾出现笼统“解析失败”提示。无法据此确定真实原因；可能与版面倾斜/弯曲、正文占比、页面分割、低密度页或 OCR 服务异常有关。产品不应把所有失败都归因于“请上传清晰图片”。

Step 6：OCR 后结构化病例并允许修改 — 健康度：良好



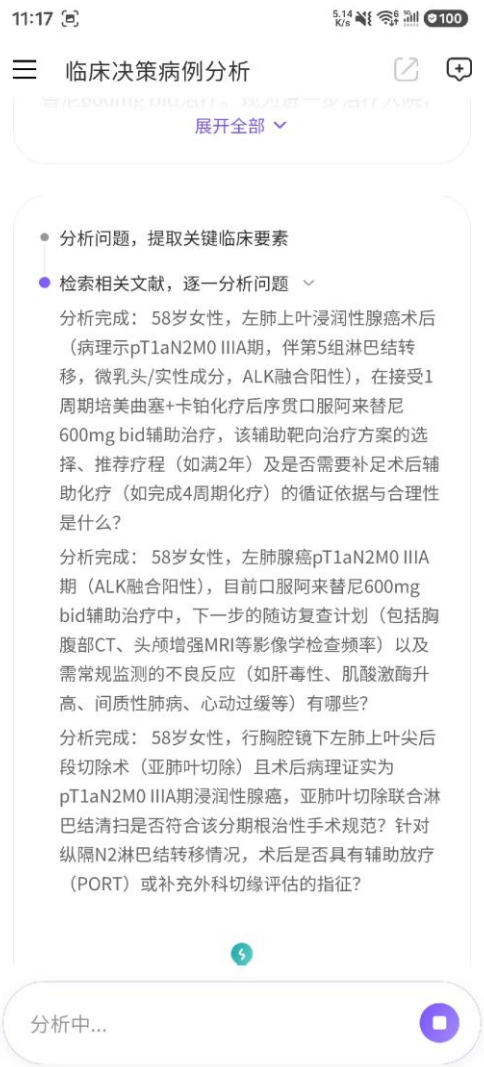
病例结构化上半部分



病例结构化下半部分

- 系统把图片内容整理为基本信息、主诉、现病史、既往史、检查、当前诊断、治疗方案和待解决问题，显著改善原始图片的可读性。
- “修改病例 / 开始分析”形成关键的人机确认点，这是高风险医疗场景中的正确方向。
- 长文本以单列连续排布，缺少时间轴、异常值突出、信息缺失提示和关键矛盾提示；医生核对成本仍高。
- “修改病例”按钮对关键安全动作的视觉权重低于“开始分析”，可能诱导用户跳过核对。

Step 7：展示分析阶段与检索过程 — 健康度：一般



分析过程



分析阶段切换

- “提取关键临床要素 → 检索相关文献 → 综合证据生成建议”的阶段可视化，让等待过程可理解，也强化循证定位。
- 可停止生成，给用户保留控制权。
- 用户实测病例解析约 30 秒、完整病例分析约 2 分钟；对复杂医学任务而言可以接受，但已足以让预计时间、后台运行和完成通知产生明显价值。
- 当前界面暴露了大量模型生成的中间问题，文字冗长且重复“分析完成”；这更像调试日志，不像临床工作摘要。
- 进度仅显示阶段，没有预计时间、已完成证据数、失败重试、后台运行或离开后通知。

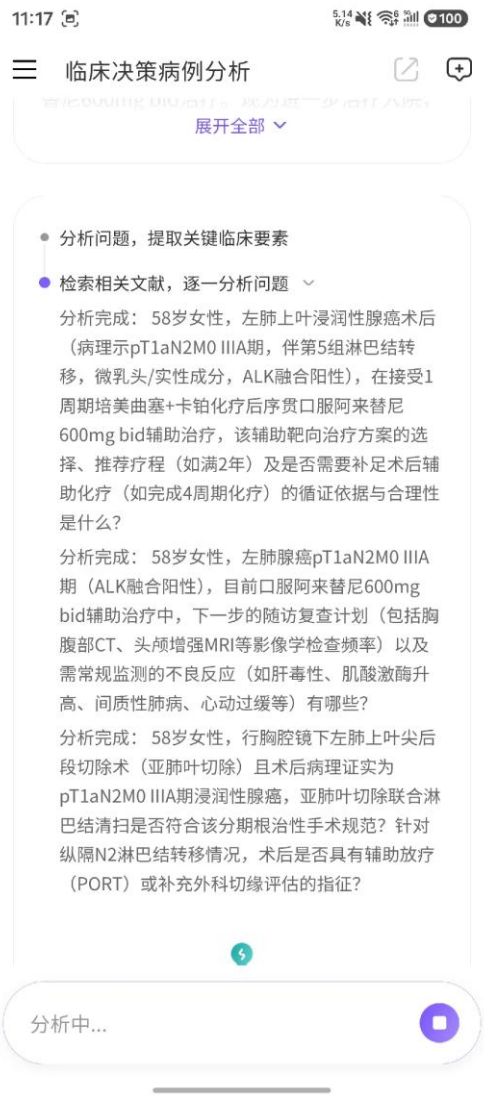
Step 8：用“多重同行评议”包装可信度 — 健康度：需验证



分析宣言

- “采用 4 重同行评议的证据，拒绝脏数据干扰”是很强的信任与营销表达。
- 截图无法证明“四重”的定义、执行者、冲突处理、证据纳入排除标准或失败条件。若无法展开解释，该表述容易成为不可验证的信任口号。
- 医疗 AI 更需要明确显示“哪些证据支持哪条结论、哪些问题证据不足、何时停止给出建议”，而不只是评议次数。

Step 8-A：最新版病例分析的输出质量 — 健康度：一般，较上一版有改进

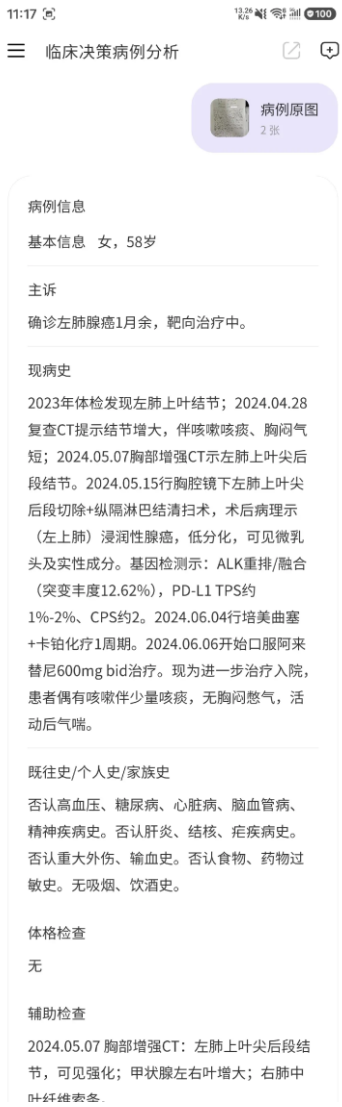


病例分析生成与证据检索过程

- **明显改进**：引用序号能够对应到 19 条参考文献，上一版暴露的 `[ccitation:4]` 占位符已经消失；化疗建议也由“补足剩余 3 周期”的确定性表述，调整为结合意愿、耐受性和可及性的个体化决策，证据边界更合理。
- **结构较完整**：输出覆盖诊断与分期、手术方式、辅助靶向治疗、化疗、PORT、随访和不良反应监测，并把结论与参考文献编号关联，临床扫读路径较清楚。
- **关键缺失未被阻断**：病例文本没有明确给出切缘状态/R0 结论，却在后续多处按“完全切除/R0”展开治疗判断；M0 依据也未展示完整的远处分期资料。更安全的产品行为应先把这些列为待确认信息，再决定是否输出确定性结论。

- **存在证据外推**：输出根据回顾性数据库研究与辅助靶向治疗效果，进一步推导“该手术选择在有高效辅助治疗背景下可以接受”。这些证据分别回答手术比较和辅助治疗问题，并未直接验证二者组合能够弥补高危亚肺叶切除的局部控制风险。
- **证据等级混用**：会议研究、回顾性数据库、随机试验、指南、说明书和专家共识同时进入结论，但界面主要通过编号引用，没有在具体结论旁清楚标出证据等级与局限。
- **引用元数据仍有瑕疵**：部分标题被截断，病例文本还出现由字符串自动识别造成的异常链接；个别句子同时引用多个来源，但读者仍需自行判断每个来源究竟支持哪一部分。
- 因此，该输出适合作为医生复核的分析草稿，不应被产品包装成已经完成独立验证的最终临床方案。本报告不对其中具体诊疗结论作医学背书。

Step 8-B：同一病例重复生成的一致性 — 健康度：较差

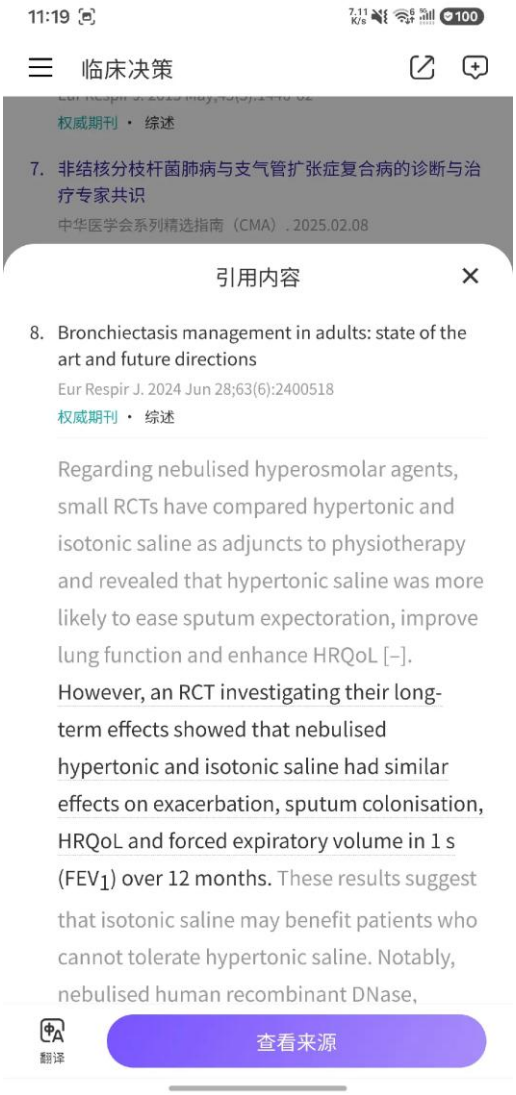


同一病例的结构化事实基线

- **核心事实发生漂移**：原始病例列出了 5、6、7、10、11、12、14 区淋巴结，其中 5 区 1/1 阳性，其余送检区域阴性；本次生成却写成“仅报告 5 区淋巴结 1 枚送检”，并据此判断未达到采样标准。这不是措辞差异，而是对输入事实的漏读，直接影响分期充分性、PORT 和后续治疗判断。
- **前后版本结论冲突**：前一次生成认为已经清扫 7 站、满足至少 6 站要求；本次却认为只有 1 站送检。产品没有显示病例事实表、冲突提示、版本差异或置信度，医生难以识别究竟是哪一次解析错误。

- **推理出现未经病例支持的扩张**：本次由淋巴结取样不足进一步推到“可能存在未送检区域 N3 转移”，但没有先说明缺少哪些 N3 区域的检查，也没有把该判断降级为待补充信息。
- **治疗叙述存在决策张力**：同一输出先称“阿来替尼单药 2 年已确立为标准、无需联合化疗”，随后又以“仅完成 1 周期、未完成标准 4 周期”评价当前方案，缺少清晰的首选路径、可选路径和适用条件区分。
- **可见的生成后质检失败**：安全性段落直接保留“13.3% vs 8.3%？”以及“实际为……”的自我纠正痕迹；这类疑问号和编辑残留应在向用户发布前被自动拦截。
- **再次依赖未确认前提**：PORT 结论继续以 R0/完全切除为前提，但病例可见信息没有明确给出切缘状态；产品仍未先追问或明确标注“基于假设”。
- 因此，重复生成测试说明该产品的主要风险已从“能否找到文献”转向“病例事实是否稳定、结论是否经过发布前一致性校验”。即使每条引用都可正确跳转，也不能弥补输入事实漏读和版本间冲突。

Step 9：查看引用原文并跳转来源 — 健康度：优秀



引用内容

- 引用弹层包含标题、期刊、年份、文献类型、命中原文、翻译和“查看来源”，是截图中最强的信任设计。
- 该设计缩短了“结论 → 原文上下文 → 外部来源”的核验路径。
- 用户实测确认：来源跳转准确，能够定位到支持对应结论的具体原文段落。该项可视为已验证的产品优势。
- 尚未独立验证翻译质量、长期链接稳定性以及所有病例与来源类型下的覆盖率。

Step 10：选择会员套餐并支付 — 健康度：良好，信任承诺需谨慎



会员权益与完整购买页



会员价格档位

- 可见套餐包括年卡 ¥798（约 ¥2.2/天）、月卡 ¥98（约 ¥3.3/天）、首次连续包年 ¥398（约 ¥1.1/天，次年续费 ¥598）和首次连续包月 ¥9（约 ¥0.3/天）；截图右侧仍有未完整显示的套餐，不能据此断言档位已经穷尽。
- 连续包年以约五折首年价格获客，同时赠送 1 年“用药助手会员”；这将 AI 决策、指南、药物数据库和医学工具打包为丁香园专业工具生态，而非只售卖单次模型问答。
- 会员每日额度为 20 次，用完次日恢复，表明产品通过配额控制推理成本，同时维持“每天可使用”的订阅心智。
- 微信支付默认选中；用户需勾选《会员服务协议》和《会员自动续费服务协议》。页面说明到期前 1 天自动扣费、需至少提前 24 小时关闭续订。

- 套餐横向滑动且相邻卡片只露出部分内容，价格、首购价和续费价不容易同屏比较；固定底部按钮始终突出当前 ¥398 方案，年度方案的视觉引导很强。
- “100% 权威证据库”“100% 真实可溯源”是付费价值主张，但已提供的病例输出出现引用错位和 `[ccitation:4]` 占位符泄露。这形成明显的“付费承诺—实际质量”落差，应作为竞品风险重点记录。

四、竞争优势

3. **把多个临床任务收敛到统一入口。** 用户不必先理解产品模块，只需从意图出发。
4. **病例图片到结构化分析的链路完整。** 它不仅回答问题，还承担资料摄取、整理、确认和检索。
5. **把检索过程可视化。** 阶段进度、来源类型、引用原文和外链共同提升可解释感。
6. **内容产品补足低频病例分析。** “每日医奏”让产品不依赖用户每天都有复杂病例。
7. **商业化位置成熟。** 会员入口显眼，但没有压住核心任务。

四-A、商业模式拆解

收费结构

套餐	截图价格	折算	说明
首次连续包月	¥9	约 ¥0.3/天	新人特惠；后续续费价格未完整显示，不作推断
月卡	¥98	约 ¥3.3/天	按 12 个月购买约 ¥1176/年
年卡	¥798	约 ¥66.5/月	相比连续购买月卡节省约 ¥378/年
首次连续包年	¥398	约 ¥33.2/月	约为年卡标价的五折；次年续费 ¥598

付费价值包

- **临床决策会员**：智能问答、处方点评、病例分析、文献检索，每日 20 次。

- **赠送的用药助手会员**：临床指南、800+ 医学工具、4000+ 诊疗专题、合理用药数据库，并提供订阅、翻译和 PDF 下载等权益。
- **跨端使用**：会员页明确给出 `ai.dxy.cn` 与 `drugs.dxy.cn`，说明移动端获客后可延伸到桌面工作场景。

商业逻辑

8. 用 ¥9 首月降低付费试用门槛。
9. 用 ¥398 首年连续包年和“赠 1 年用药助手”提高年度方案转化。
10. 用次年 ¥598 自动续费提升生命周期收入。
11. 用每日 20 次配额约束高成本 AI 使用。
12. 用指南、药物库和传统医学工具为 AI 结果增加品牌背书与感知价值。

用户实测补充

- 用户反馈取消自动续费路径可正常完成，退款流程亦可正常处理；本报告尚未获得订单或退款页面证据，因此将其记录为实测口述，而非独立验证结果。
- 首月优惠结束后“按标准月卡价格续费”目前仍是合理推测，尚未由明确的续费金额页面或扣款记录确认，不应写成确定事实。
- 解析失败、停止生成和重试均不扣额度，降低了用户探索复杂任务时的成本焦虑。

对 OncoRounds 的启示

- 不必复制“通用医学工具大礼包”；更适合按**病例或题组产出价值**收费，例如科室版病例额度、验证题组包、证据更新订阅和团队审核席位。
- 免费或低价层可以提供病例结构化预览，但“完整五题 + 独立验证 + 题目级证据定位 + 导出”可作为核心付费权益。
- 若采用自动续费，应让首购价、续费价、额度和取消路径同屏可见，避免把商业转化建立在价格理解成本上。
- 不要使用“100% 权威”“100% 可溯源”等绝对化口号；应展示可验证的通过率、引用完整率和发布门禁。

五、主要短板与风险

P0：隐私与安全承诺过度

- 输入—输出对照显示：原始病历含多类直接标识符，而结构化输出未展示它们。这支持“输出层进行了字段抑制”的有限判断，但**不能证明系统未识别、未传输或未留存这些信息。**
- “不会识别任何隐私信息”应改为可验证、分阶段的说明，例如“输出中默认隐藏识别到的敏感字段”，并明确识别、传输、模型处理、存储、访问、保留和删除规则。
- 更稳妥的设计应是：上传前提醒脱敏 → 自动检测并框选敏感字段 → 生成不可逆遮挡副本 → 让用户确认 → 仅提交脱敏副本 → 显示保存期限和一键删除入口。检测到姓名、证件/就诊号、电话、地址、条码/二维码、签名等字段时，应默认阻断提交，而非仅给文案承诺。

P0：证据可信度的展示仍偏营销

- “权威期刊”“4 重同行评议”不是足够的证据质量说明。
- 会员页进一步使用“100% 权威证据库、100% 真实可溯源”，但实际病例结果出现引用错位和引用占位符泄露，构成直接的信任风险。
- 应显示证据类型、研究设计、发布日期、适用人群、关键局限、具体定位，以及结论与证据的一对一映射。

P1：病例核对效率不足

- 长文本不利于识别 OCR 错误、时间矛盾、剂量异常和关键信息缺失。
- 适合改造成时间轴 + 结构化字段 + 异常高亮 + 原图对照，而不是单列病历全文。

P1：病例图片失败恢复不够可行动

- 已提供“重新上传”，但没有告诉用户图片具体哪里不合格，也没有在提交前拦截明显的清晰度、裁切或格式问题。
- 应返回可行动原因，例如“文字区域过小”“存在强反光”“未检测到病历正文”，并提供裁切、旋转、拍摄示例和“不扣额度重试”说明。

P1：账号与病例数据控制已有入口，但删除范围不透明

- 竞品已经提供账号注销、个人信息下载、个人信息收集清单、第三方共享说明以及单条会话删除，这部分能力比上一轮证据显示得更完整。
- 仍需明确下载数据的覆盖范围，以及会话删除和账号注销是否连带删除上传原图、OCR 文本、模型输入输出、缓存、日志和第三方处理副本；同时披露法定留存例外与完成时限。

P1：专业认证采集高敏感信息，治理说明不足

- 执业医师认证需要提交身份与职业信息，但目前可见界面主要依赖“仅用于认证”的概括承诺。
- 应在提交前展示字段用途、必要性、审核方、数据来源、保存期限、访问范围、撤回/更正路径和认证失败后的删除规则，并对不必要字段执行最小化采集。

P1：分析过程暴露过多内部思考

- 大量“分析完成：……”问题增加阅读负担，也可能让用户误把系统提出的问题当作已经验证的临床结论。
- 更合适的状态是：已识别的核心问题、正在检索的证据类别、证据是否充足、预计剩余时间。

P2：移动端长内容可读性一般

- 长段落、灰色小字、浅边框和低对比标签较多。
- 应支持结论摘要、分层折叠、目录锚点、关键数字高亮和证据卡片。

P2：历史资产管理仍偏基础

- 病例、处方与文献混在同一历史列表中，已支持单条重命名和删除，但仍缺少搜索、筛选、专科、患者脱敏编号、收藏、归档、批量操作和导出等可见能力。

六、无障碍与可用性风险

- 多处浅灰文字与白色背景、浅紫标签与浅色底，存在对比度不足风险；需用真实色值验证 WCAG 对比度。

- 小号标签、细线边框和右侧细箭头在强光、低视力或长时间阅读场景下辨识度有限。
- 主要按钮尺寸看起来充足，但关闭图标、删除图片的圆形“×”和列表箭头的触控热区需要实测。
- 提供“字体设置”是积极信号；仍需验证是否支持系统动态字号、长文本重排，以及放大后是否出现截断或按钮遮挡。
- 截图无法验证读屏标签、焦点顺序、键盘/外接设备、动态进度播报、字体放大和横屏重排。
- 分析状态主要依赖颜色圆点表示，建议同时提供文字状态和无颜色依赖的图形变化。

七、对“大查房 / OncoRounds”的启示

不要照搬的部分

- 不要做“病例、处方、指南什么都能问”的通用首页，容易稀释肿瘤教学定位。
- 不要直接展示长篇模型思考或把“多代理/多重评议次数”当作可信度本身。
- 不要对隐私做绝对承诺，也不要在未完成证据验证时发布看似确定的结论。

应借鉴并升级的部分

13. **借鉴病例图片上传，但增加脱敏门禁。** 上传前提供脱敏清单；OCR 后将姓名、住院号、电话、二维码、精确日期等标为待确认字段。

更进一步，应在本地或可信边界内先生成不可逆遮挡副本，默认只上传副本；同时增加图片质量预检，提交前检查清晰度、倾斜、弯曲、反光、正文占比、页码完整性和文档分割。失败时保留已填内容、给出具体原因，并明确不消耗病例额度。

14. **借鉴结构化病例确认，但改为肿瘤专用结构。** 采用诊断、分期、病理、分子、既往线次、疗效、不良反应、当前决策点的时间轴，并保留原图对照。
15. **借鉴分析阶段可视化，但显示验证状态。** 用“病例要素完整性 → 指南检索 → 临床研究检索 → 生成五题 → 独立验证 → 发布门禁”替代泛化的思考日志。
16. **借鉴引用原文弹层，并做到题目级证据映射。** 每道题显示来源类型、标题、年份、定位、支持的答案点和局限。

17. **把证据不足做成正式结果。** 清楚显示 `PASS / REVISE / STOP_INSUFFICIENT`，证据不足时宁可少发布或停止，也不凑满五题。
18. **用教学留存替代资讯流留存。** 可做“本周病例复盘、错题回看、专科题组订阅、证据更新提醒”，比泛医学资讯更符合大查房定位。
19. **把专业身份与数据控制做成基础设施。** 可借鉴职业分流认证与隐私中心，但认证信息应最小化采集，并显示字段用途与保存期限；同时为病例、题组、原图和证据缓存提供查看、导出、删除、保留期限与审计记录。

八、建议的差异化产品主张

> **临床决策帮助医生“得到一个回答”；OncoRounds 帮助科室“产出一套经验证、可追溯、可教学的肿瘤大查房题组”。**

支撑这一主张的四项产品证据应在界面上直接可见：

20. 固定五题及难度/知识点分布；
21. 病例事实、指南、原创临床研究的证据配额；
22. 每题证据定位与答案理由；
23. 独立验证结果和发布门禁。

九、建议优先级

优先级	建议	目标
P0	设计上传前脱敏 + OCR 后敏感字段确认	建立比竞品更可信的隐私边界
P0	在最终五题页展示验证状态、证据类型与定位	把循证严谨性变成可见差异
P0	证据不足时支持停止发布	避免“凑题”和虚假确定性
P1	用肿瘤时间轴核对病例，而非长病历全文	降低病例确认成本和 OCR 风险
P1	把生成过程压缩成任务状态，不暴露长	降低等待焦虑和认知负担

优先级	建议	目标
	篇内部思考	
P1	增加题组预览、修改意见和版本对比	强化教学工作流而非一次性问答
P1	建立账号、角色、认证与病例数据控制中心	让专业身份和隐私治理可发现、可操作
P2	增加错题复盘、病例专题和证据更新提醒	建立垂直留存机制

十、证据边界与下一步验证

本报告已通过用户实测口述确认：会话删除后不可恢复；病例解析约 30 秒、病例分析约 2 分钟；解析失败、停止生成和重试不扣额度；取消自动续费与退款可正常处理；引用来源跳转准确，且能定位到支持结论的具体原文段落。仍不能确认：连续包月优惠后的明确续费金额、订单/退款流程细节、模型和检索库来源、回答医学准确率、同一病例重复生成的事实一致率、敏感信息在上传/OCR/传输/日志/模型调用/存储各阶段的真实处理方式、保存地域与期限、第三方处理者、个人信息下载的覆盖范围、会话删除是否连带清除原图/OCR/模型记录及第三方副本、账号注销的后端删除范围和完成时限、认证审核方与材料保留规则、人工审核比例、历史会话搜索筛选、生成内容导出分享、团队协作及无障碍实现。结构化输出未展示直接标识符，仅能证明“可见输出层未呈现”，不能外推为全链路未处理或未保存。

若进入下一轮竞品验证，建议用同一个脱敏肿瘤病例对两款产品进行任务对测，统一记录：病例录入耗时、OCR 错误数、首次可用结果时间、证据命中率、引用可核验率、错误/证据不足处理、修改成本和最终教学产物质量。